



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
PELAYANAN *STUNTING* DAN *WASTING*
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

**PROGRAM KERJA PELAYANAN STUNTING DAN WASTING
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dikatakan berhasil jika memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Indonesia masih mengalami masalah yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dikarenakan pemenuhan gizi sejak dalam kandungan hingga lahir masih belum tercukupi. Masalah gizi yang sedang Indonesia hadapi adalah *triple burden malnutrition* yaitu *wasting*, *stunting*, dan obesitas. Dari ketiga masalah gizi tersebut yang memiliki jumlah cukup tinggi dan berdampak pada bayi adalah *stunting* atau tubuh pendek.

Stunting atau pendek merupakan kondisi dimana bayi (0-11 bulan) dan balita (12-59 bulan) mengalami gagal tumbuh akibat dari kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (WHO, 2014). Kekurangan gizi anak *stunting* juga dapat terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. Akan tetapi, *stunting* baru nampak saat bayi berusia dua tahun (Yuliana dan Hakim, 2019). Kategori *stunting* dapat dilihat dengan indikator tinggi badan menurut umur (TB/U) atau panjang badan menurut umur (PB/U) dengan *z-score* < -3 SD sampai dengan < -2 SD (Kemenkes, 2020).

Masalah gizi *stunting* memiliki pengaruh jangka panjang pada tumbuh kembang balita yaitu dapat mengganggu kesehatan, pendidikan, dan produktifitasnya di masa yang akan datang. Balita *stunting* cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan perkembangan yang optimal baik secara fisik maupun psikomotorik (Aridiyah, 2015). Kondisi *stunting* juga memiliki pengaruh tidak langsung terhadap penyakit tidak menular. Berbagai studi membuktikan bahwa anak yang kurang gizi pada waktu balita dan kemudian mengalami *stunting*, maka pada usia dewasa akan lebih mudah mengalami obesitas dan terserang diabetes mellitus (Yuliana dan Hakim, 2019).

Prevalensi *stunting* di dunia diperkirakan sebesar 22,3% atau sekitar 148 juta balita mengalami *stunting* berdasarkan estimasi bersama lembaga internasional terbaru (WHO, UNICEF, World Bank, 2023). Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi *stunting* masih bervariasi antar negara, dimana Indonesia termasuk negara dengan beban *stunting* relatif tinggi dibanding beberapa negara lain meskipun prevalensi balita *stunting* di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, yaitu dari 24,4% pada tahun 2021 menjadi 21,6% pada tahun 2022 dan sekitar 21,5% pada tahun 2023 berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Selain itu, proporsi balita sangat pendek dan pendek secara nasional juga menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan periode sebelumnya, meskipun masih terdapat disparitas antar wilayah sehingga upaya percepatan penurunan *stunting* tetap menjadi prioritas program kesehatan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2023; WHO, 2023).

Stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh balita, namun juga berasal dari ibu hamil. Salah satu penyebab *stunting* adalah rendahnya asupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan yaitu sejak janin hingga bayi usia dua tahun (TNP2K, 2018). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Beal, dkk. (2018), faktor penyebab *stunting* di Indonesia berdasarkan faktor ibu yaitu asupan yang tidak adekuat selama pra-konsepsi, kehamilan, dan



menyusui, perawakan ibu pendek, kehamilan pada usia remaja, IUGR serta kelahiran prematur.

Wasting adalah salah satu bentuk kekurangan gizi yang mencerminkan berat badan anak terlalu kurus menurut tinggi badannya, ditandai dengan z-score BB/TB kurang dari -2 SD untuk *wasting* dan z-score BB/TB kurang dari -3 SD untuk severe wasting (Menteri Kesehatan RI, 2020).

Wasting pada anak-anak merupakan hasil dari penurunan berat badan yang cepat atau ketidakmampuan menambah berat badan (Unicef/ WHO/The World Bank, 2019). *Wasting* mengakibatkan balita berisiko mengalami ketertinggalan tumbuh kembang secara jangka panjang, penurunan fungsi sistem imunitas, peningkatan keparahan dan kerentanan terhadap penyakit menular, serta peningkatan risiko kematian terutama balita yang mengalami severe wasting (UNICEF/ WHO/The World Bank, 2019). Tumbuh kembang yang terjadi saat balita akan berdampak pada individu di masa yang selanjutnya. Jika anak mengalami ketidaksesuaian atau kegagalan tumbuh kembang, tidak teridentifikasi dan tidak mendapat tindakan yang baik, maka anak tidak dapat mencapai pertumbuhan yang maksimal. Hal tersebut dapat berdampak pada berkurangnya kualitas generasi penerus bangsa di masa depan (Menteri Kesehatan RI, 2014).

Kekurangan gizi termasuk *wasting* dipengaruhi oleh faktor langsung, salah satunya ialah asupan makanan yang tidak adekuat (UNICEF, 2015). Zat gizi yang diperoleh tubuh dari asupan makan dibutuhkan untuk melakukan kegiatan dan memelihara kesehatan (Hendrayati, Amir and Darmawati, 2013). Tingkat asupan zat gizi makro yakni energi, karbohidrat, protein, dan lemak yang tidak adekuat terhadap kebutuhan tubuh, dalam jangka panjang dapat mengakibatkan perubahan jaringan dan massa tubuh, yang selanjutnya berefek pada penurunan berat badan (Barasi, 2007).

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2013 tentang Pedoman Pelayanan Gizi Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1928/2022 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Stunting;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/43961/2024 tentang Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;



13. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 953.4/RSPHS/I/KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;
14. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Program Kerja Tim Pelayanan *Stunting* dan *Wasting* disusun sebagai pedoman operasional bagi rumah sakit dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelayanan pencegahan serta penatalaksanaan *stunting* dan/atau *wasting* secara komprehensif, terintegrasi, dan berbasis bukti. Program kerja ini menjadi acuan bagi tim multidisiplin dalam memberikan pelayanan yang bermutu, aman, efektif, dan berkesinambungan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, standar keselamatan pasien, serta ketentuan akreditasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

Mewujudkan pelayanan *stunting* dan *wasting* yang terkoordinasi dan berkualitas melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan status gizi pasien, menurunkan risiko komplikasi, serta mendukung pencapaian target program prioritas nasional di rumah sakit.

3. Tujuan Khusus

- a. Menyediakan pedoman kerja yang sistematis dan terstandar bagi tim multidisiplin dalam melaksanakan skrining, deteksi dini, asesmen komprehensif, diagnosis, intervensi, serta tindak lanjut kasus *stunting* dan/atau *wasting*.
- b. Memastikan pelaksanaan skrining gizi awal secara menyeluruh pada kelompok berisiko tinggi, meliputi balita (0 – 59 bulan) dan ibu hamil, sesuai standar praktik klinis dan pedoman nasional.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar profesi (dokter, ahli gizi, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga kesehatan lainnya) dalam penatalaksanaan kasus secara terpadu dan berkesinambungan.
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan *stunting* dan *wasting* agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan medik.
- e. Meningkatkan edukasi, komunikasi, dan konseling gizi kepada pasien dan keluarga untuk mendukung perubahan perilaku dan keberhasilan terapi.
- f. Menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkesinambungan sebagai bagian dari peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Visi

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 Misi

1. Memberikan pelayanan kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat.
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien.
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

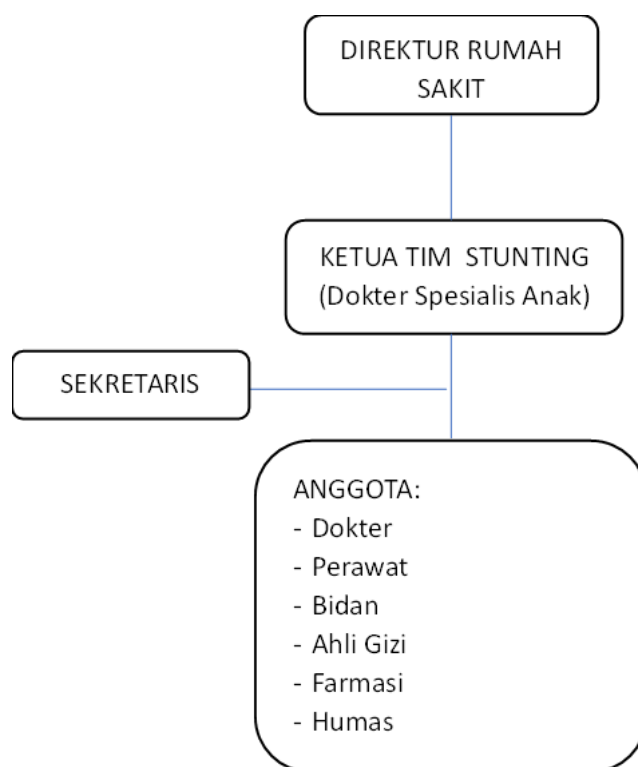
2.3 Motto

Sahabat menuju sehat

2.4 7 Nilai Budi Utama

1. Jujur
2. Tanggung Jawab
3. Visioner
4. Kerjasama
5. Adil
6. Peduli

2.5 SOTK



Bagan 1. SOTK Tim Pelayanan Stunting dan Wasting

BAB III

KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 SDM

3.1.1 Ketenagaan

Ketua	: dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed
Sekretaris	: Annisa' Dwi Khumairoh, A.Md.Gz.
Anggota	:
Staff Medis	: dr. Achmad Fauzan Ailani
Staff Keperawatan	: Ayu Mayang Priningtiyas, S.Kep., Ns.
Staff Kebidanan	: Iin Widowati, S.Tr.Keb.
Staff Instalasi Gizi	: Riska Amelia Putri, S.Tr.Gz.
Staff Instalasi Farmasi	: Shinta Aprilia Rizky Wulandari, S.Farm., Apt.
Anggota Tim Humas	: Novi Dwi Hidayati, S.Tr.Kes.

3.1.2 Orientasi

Orientasi dilakukan kepada anggota baru dengan diberikan penjelasan mengenai jabatan, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang

3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan

Saat ini Prognas *Stunting* dan *Wasting* ada 8 orang dengan tingkat Pendidikan:

- a) S2 = 1 orang
- b) S1 = 3 orang
- c) D4 = 3 orang
- d) D3 = 1 orang

Belum ada pelatihan eksternal *stunting* dan *wasting*. Pelatihan Internal *Stunting* diselenggarakan di RS Prima Husada.

3.2 Kegiatan Pelayanan

No.	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Melakukan promosi kesehatan dengan melaksanakan penyuluhan mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>
2.	Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik	1. Memberikan edukasi tentang program 1000 HPK 2. Memberikan edukasi tentang pentingnya konsumsi tablet besi folat pada ibu hamil 3. Memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil 4. Melakukan edukasi promosi konseling pentingnya IMD dan ASI eksklusif 5. Memberikan makanan bayi dan anak (PMBA) 6. Melakukan pemantauan pertumbuhan pada bayi dan balita 7. Memberikan imunisasi 8. Memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang 9. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemberian Vitamin A untuk mendukung



No.	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
		program pemerintah 10. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemberian taburia pada baduta (0-23 bulan) untuk mendukung program pemerintah 11. Memberikan edukasi tentang pemberian obat cacing pada ibu hamil untuk mendukung program pemerintah
3.	Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Mendukung pemeliharaan ruangan (pojok laktasi) agar memberikan rasa aman dan nyaman pada ibu menyusui Memberikan edukasi dan dukungan pemberian asi eksklusif
4.	Rumah Sakit sebagai Pusat Rujukan Kasus <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>	1. Rumah Sakit sebagai pusat rujukan kasus stunting untuk memastikan kasus, penyebab, dan tatalaksana lanjut oleh Dokter Spesialis Anak 2. Rumah Sakit sebagai pusat rujukan balita gizi buruk dengan komplikasi medis 3. Rumah sakit dapat melakukan pendampingan klinis dan manajemen serta penguatan jejaring rujukan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayahnya dalam tatalaksana <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> .
5.	Rumah Sakit sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen serta Jejaring Rujukan	1. Membuat suatu perjanjian kerjasama dengan jejaring rujukan rumah sakit terkait hal-hal yang disepakati dalam proses rujukan pasien 2. Melaksanakan penguatan terhadap jejaring rujukan rumah sakit.
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program	1. Melakukan monitoring evaluasi terkait edukasi yang telah diberikan dan melakukan pengukuran antropometri secara berkala untuk mengetahui efektifitas terapi yang diberikan 2. Membuat laporan dan evaluasi kegiatan

3.3 Sasaran

NO.	KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	a. Staff RS b. Ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua/keluarga balita c. Masyarakat umum di wilayah pelayanan	Promotif, preventif	- Kegiatan dilakukan secara rutin (minimal 1 bulan sekali) - Peserta memahami materi yang diberikan	- Sasaran memahami dan melaksanakan pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> - Dokumentasi kegiatan	
2.	Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik	Meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i> melalui pelaksanaan intervensi gizi spesifik pada ibu hamil, bayi, dan balita secara terintegrasi sesuai dengan program nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>	a. Bayi, baduta, dan balita b. Ibu hamil c. Ibu menyusui d. Orang tua/keluarga pasien	Promotif, preventif, dan kuratif	Intervensi gizi spesifik dilaksanakan secara rutin dan terintegrasi sesuai standar pelayanan kesehatan dan program nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>	Intervensi gizi spesifik terlaksana secara rutin dan terintegrasi	
3.	Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Meningkatkan dukungan lingkungan rumah sakit terhadap keberhasilan pemberian ASI eksklusif sebagai upaya pencegahan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan balita	Promotif, preventif	Tersedianya ruang laktasi yang aman dan nyaman sehingga mendukung terlaksananya pemberian ASI Eksklusif	Tersedianya pojok laktasi yang berfungsi dengan baik di rumah sakit	
4.	Rumah Sakit sebagai	Meningkatkan efektivitas	Bayi, baduta, balita	Kuratif dan	Pelayanan rujukan	Pelayanan rujukan	



	Pusat Rujukan Kasus <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>	penanganan kasus stunting dan wasting melalui pelayanan rujukan yang terintegrasi, komprehensif, dan sesuai standar pelayanan kesehatan	dengan stunting dan/atau wasting yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau jejaring pelayanan kesehatan	rehabilitatif	kasus stunting dan wasting dilaksanakan sesuai standar tata laksana dan prosedur rujukan yang berlaku	kasus stunting dan wasting terlaksana sesuai tata laksana klinis, serta terdapat pencatatan, pelaporan, dan tindak lanjut kasus secara terintegrasi	
5.	Rumah Sakit sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen serta Jejaring Rujukan	Meningkatkan kualitas penanganan stunting dan wasting melalui pendampingan klinis, penguatan manajemen pelayanan, serta koordinasi jejaring rujukan dengan fasilitas kesehatan	Fasilitas pelayanan kesehatan jejaring (puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya)	Kolaborasi, koordinasi	• Melaksanakan koordinasi jejaring secara berkala minimal 1 kali per tahun untuk meningkatkan kesinambungan pelayanan dan tindak lanjut pasien • Mendokumentasikan pelaksanaan koordinasi jejaring	• Kegiatan koordinasi jejaring terlaksana sesuai rencana • Dokumentasi pelaksanaan koordinasi jejaring	
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program	Mengetahui pelaksanaan, capaian, serta efektivitas program pelayanan stunting dan wasting sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan	Tim pelayanan stunting dan wasting serta unit pelayanan terkait di rumah sakit	Monitoring dan evaluasi	Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dilaksanakan secara berkala sesuai rencana program	• Tersedianya data dan laporan pelaksanaan program stunting dan wasting secara berkala • Tersedianya dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi program	



3.4 Cara melaksanakan Kegiatan

NO	KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Melaksanakan promosi kesehatan melalui penyuluhan kepada staf, pasien dan keluarga pasien mengenai pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	Promotif (penyuluhan dan edukasi)	Leaflet, audio	minimal 1 kali per bulan	Materi, dokumentasi	
2.	Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik	a. Memberikan edukasi tentang program 1000 HPK b. Memberikan edukasi suplementasi tablet besi folat pada ibu hamil c. Memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil d. Melakukan promosi konseling IMD dan ASI eksklusif e. Memberikan makanan bayi dan anak (PMBA) f. Melakukan pemantauan pertumbuhan pada bayi dan balita g. Memberikan imunisasi h. Memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang i. Memberikan edukasi tentang pentingnya pemberian Vitamin A j. Memberikan edukasi tentang	Preventif dan kuratif	Leaflet, alat antropometri	Sesuai pelayanan	Rekam medis, dokumentasi	



NO	KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
		pentingnya pemberian taburia pada baduta (0-23 bulan) k. Memberikan edukasi tentang pemberian obat cacing					
3.	Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Menyediakan dan memelihara fasilitas pojok laktasi serta memberikan edukasi dan dukungan kepada ibu menyusui tentang ASI eksklusif	Promotif dan preventif	Pojok laktasi, leaflet ASI, poster edukasi	Sesuai pelayanan	Dokumentasi pojok laktasi	
4.	Rumah Sakit sebagai Pusat Rujukan Kasus <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>	Memberikan pelayanan pemeriksaan, diagnosis, tata laksana serta pemantauan kasus stunting dan wasting yang dirujuk dari fasilitas kesehatan jejaring	Kuratif dan rehabilitatif	Rekam medis, alat antropometri, panduan tata laksana stunting	Sesuai pelayanan	Rekam medis pasien	
5.	Rumah Sakit sebagai Pendamping Klinis dan Manajemen serta Jejaring Rujukan	Melakukan koordinasi, pembinaan dan pendampingan kepada fasilitas kesehatan jejaring terkait penanganan kasus stunting dan wasting	Kolaboratif, koordinatif	Panduan pelayanan, MoU	Minimal 1 kali pertahun	Dokumentasi kegiatan, UMANDOK	
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program	Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pelayanan stunting dan wasting untuk menilai capaian indikator program	Monitoring dan evaluasi	Laporan kegiatan program	Setiap bulan, triwulan, dan tahunan	Laporan bulanan, triwulan, dan tahunan	

3.5 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	Pelaksana	Sumber Dana	Metode
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh staf, pasien dan keluarga mengenai pentingnya pencegahan serta penanganan <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	- Staff RS - Ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua/keluarga balita - Masyarakat umum di wilayah pelayanan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang rawat inap dan rawat jalan	1. Unit Terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	RS Prima Husada	Promotif (penyuluhan dan edukasi)
2.	Peningkatan Efektifitas Intervensi Gizi Spesifik	- Bayi, baduta, dan balita - Ibu hamil - Ibu menyusui - Orang tua/keluarga pasien	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Ruang rawat inap dan rawat jalan	1. Unit Terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	RS Prima Husada	Preventif dan kuratif
3.	Penerapan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi	Ibu hamil, Ibu menyusui, bayi dan balita			√			√			√			√	Rumah Sakit Prima Husada	1. Unit Terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	RS Prima Husada	Promotif dan preventif
4.	Rumah Sakit sebagai Pusat Rujukan Kasus <i>Stunting</i> dan <i>Wasting</i>	Bayi, baduta, balita dengan <i>stunting</i> dan/atau <i>wasting</i> yang dirujuk dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau jejaring pelayanan kesehatan													Rumah Sakit Prima Husada	1. Unit Terkait 2. Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	RS Prima Husada	Kuratif dan rehabilitatif
5.	Rumah Sakit sebagai	Fasilitas pelayanan kesehatan jejaring												√	Wilayah jejaring	3. Unit Terkait 3. Tim <i>stunting</i>	RS Prima Husada	Kolaboratif, koordinatif



No.	Kegiatan	Sasaran	Bulan												Tempat	Pelaksana	Sumber Dana	Metode
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Pendamping Klinis dan Manajemen serta Jejaring Rujukan	(puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya)													rujukan	dan <i>wasting</i>		
6.	Pemantauan dan Evaluasi Program	Tim pelayanan stunting dan wasting serta unit pelayanan terkait di rumah sakit	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Rumah Sakit Prima Husada	Tim <i>stunting</i> dan <i>wasting</i>	RS Prima Husada	Monitoring dan evaluasi

3.6 Kebutuhan Anggaran

No.	Uraian	Kebutuhan	Harga @	Jumlah
1	Pelatihan eksternal tim stunting	4 orang	Rp. 1.000.000	Rp. 4.000.000
2	Pelatihan internal tim stunting	8 orang	-	-
3	Pengajuan penambahan alat pengukuran antropometri: 1. Infatometer 2. Baby scale 3. Microtoice 4. Pita LiLA 5. Metlin			Rp. 2.000.000 Rp. 500.000 Rp. 30.000 Rp. 60.000 Rp. 90.000
4	Leaflet	1 rim	Rp. 100.000	Rp. 100.000
TOTAL				Rp. 7.780.000



BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 Monitoring

1. Memantau pelaksanaan program, edukasi gizi, konseling kesehatan, pemantauan pertumbuhan, serta intervensi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting.
2. Memantau ketersediaan media edukasi, materi penyuluhan, dan dokumentasi kegiatan.
3. Memantau keterlaksanaan jadwal sesuai program kerja yang telah ditetapkan.
4. Melakukan supervisi pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan.
5. Memantau kelengkapan dokumentasi pelayanan dan pelaporan kegiatan intervensi gizi.
6. Melakukan pemantauan pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi seluruh kegiatan program stunting dan wasting secara berkala.

4.2 Evaluasi

1. Menilai efektivitas pelaksanaan program, edukasi gizi, konseling kesehatan, pemantauan pertumbuhan, dan intervensi yang diberikan kepada pasien stunting dan wasting berdasarkan capaian indikator yang telah ditetapkan.
2. Mengevaluasi ketersediaan, kesesuaian, dan pemanfaatan media edukasi, materi penyuluhan, serta kelengkapan dokumentasi kegiatan dalam mendukung pelayanan stunting dan wasting.
3. Menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan kegiatan terhadap jadwal program kerja yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian pelaksanaan.
4. Mengevaluasi kinerja pelaksana program berdasarkan hasil supervisi, pencapaian target kegiatan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan yang berlaku.
5. Menilai kelengkapan, ketepatan, dan kualitas dokumentasi pelayanan serta pelaporan kegiatan intervensi gizi sebagai dasar pengambilan keputusan dan peningkatan mutu pelayanan.
6. Mengevaluasi hasil pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi kegiatan program stunting dan wasting secara berkala untuk mengetahui capaian program, hambatan yang dihadapi, serta menyusun rencana tindak lanjut perbaikan..



BAB V PENCATATAN DAN PELAPORAN

5.1 Pencatatan

Semua kegiatan pelayanan *stunting* dan *wasting* dicatat sesuai jenis kegiatan dan SPO.

5.2 Pelaporan

Laporan disusun berdasarkan laporan dari unit kerja setiap bulan, triwulan, dan tahunan, serta tim *stunting* dan *wasting* melaporkan kegiatan ke Direktur.

1. Laporan Bulanan

Laporan dibuat setiap bulan untuk pelaporan kegiatan pelayanan mutu serta jumlah stok alat kontrasepsi.

2. Laporan Triwulan

Laporan dibuat dengan merekap hasil kinerja selama 3 bulan.

3. Laporan Tahunan

Laporan dibuat 1 tahun sekali pada akhir tahun dan diserahkan pada awal bulan Januari tahun berikutnya



BAB VI PENUTUP

Program Kerja Tim Pelayanan Stunting dan Wasting ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penatalaksanaan masalah gizi secara terintegrasi di rumah sakit. Diharapkan seluruh kegiatan dapat dilaksanakan secara konsisten, terkoordinasi, dan berkesinambungan guna mendukung peningkatan mutu pelayanan serta berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting dan wasting. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan terus dilakukan agar program berjalan efektif dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan yang berlaku.

Mengetahui,
PLT. Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep

Pasuruan, 1 November 2025
Ketua Tim *Stunting*

dr. Ratih Kusumawardani, Sp.An., M.Biomed